

Saúde na Última Semana

TEMA DA SEMANA

Entre acesso, regulação e autonomia

Obesidade como doença, semaglutida em estudo no SUS, o limite sanitário da T36 e a autoridade humana na cadeia que transforma possibilidade em cuidado.

EDIÇÃO 20.09.2026 SEMANA 13–20 SET 2026 AUTORIA DR LUCAS HR ALMEIDA

EDIÇÃO VERIFICADA

HUMAN - GATE

ABERTURA

Antes das
“canetas”: do que
estamos tratando
quando falamos em
obesidade?

O vocabulário importa
porque ele pode reduzir
uma doença sistêmica a
uma questão cosmética de
peso.

ENQUADRAMENTO CLÍNICO

01 · ACESSO

Medicamentos para obesidade no SUS: o anúncio chegou antes da incorporação

Promessa relevante. Fato
regulatório ainda é estudo, ATS
e protocolo.

CONTRAPONTO

T36: quando a demanda por acesso encontra o limite sanitário

Anvisa, RE 3.626/2026 · DOU
16/09. Sem registro nacional.
Mesma matéria, outro bordo.

O que esta semana realmente colocou em jogo

A questão comum não é a novidade tecnológica. É o caminho entre possibilidade, regulação e cuidado responsável.

A mesma semana colocou lado a lado movimentos que parecem independentes, mas descrevem uma questão comum: quem decide quando uma tecnologia está pronta para entrar no cuidado — e com quais garantias?

O fio da semana não é a tecnologia em si. É a qualidade da cadeia que transforma possibilidade em cuidado.



Lucas Henrique Rodrigues de Almeida ao lado de Antônio Carlos Pereira Martins no 40º Congresso do CREMESP, 2026

40º Congresso do CREMESP, 2026. À esquerda, Dr Lucas HR Almeida. À direita, o Prof. Antônio Carlos Pereira Martins, homenageado no congresso e primeiro transplantador renal com doador cadáver na FMRP-USP.



Dr
Lucas HR
Almeida

Dr Lucas HR Almeida

Editorial · Médico generalista (FMRP-USP)
CRM-SP 226836 · CRM-MG 109752

FOTO · 40º CONGRESSO CREMESP · 2026

CRITÉRIO EDITORIAL

Anúncio não foi tratado como incorporação; consulta pública não foi tratada como protocolo vigente; benchmark não foi tratado como desfecho clínico; e ato regulatório foi separado de narrativa política.

HOMENAGEM

O 40º Congresso do CREMESP de 2026 homenageou o Prof. Antônio Carlos Pereira Martins, primeiro transplantador renal com doador cadáver na FMRP-USP.

Em 1968, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, ele integrou a equipe de um transplante renal pioneiro com doador falecido. Antes do corte, houve o ato menos visível: obter da família a autorização para a doação.

A cadeia que esta edição descreve — possibilidade, garantia, recusa possível — já estava ali. Não se acelera um transplante apagando a etapa que pergunta se aquele órgão pode, de fato, cuidar.

AOS QUE ENSINAM

Reconhecimento a quem ainda se dedica com afinco ao exercício do ensino superior no Brasil — em sala, enfermaria, laboratório e banca — quando o atalho seria abandonar a cadeia formativa.

Em breve esta Revista introduzirá, com fonte e limite, avanços já realizados pela ciência brasileira que circulam no mesmo patamar das revistas que o país insiste em tratar como estrangeiras. Não é importação de prestígio. É devolver ao leitor o que a universidade pública já produziu e ainda produz.

ABERTURA

Antes das “canetas”: do que estamos tratando quando falamos em obesidade?

O vocabulário importa porque ele pode reduzir uma doença sistêmica a uma questão cosmética de peso.

Chamá-las de “canetas emagrecedoras” é um enquadramento insuficiente para política de saúde. O objeto em discussão é o tratamento farmacológico da obesidade, uma doença crônica, recidivante e sistêmica associada ao excesso ou à disfunção do tecido adiposo, com repercussões metabólicas, cardiovasculares, mecânicas, funcionais e inflamatórias.

O tecido adiposo é metabolicamente ativo. IMC continua útil como ferramenta epidemiológica e de triagem, mas não descreve composição corporal, distribuição da adiposidade nem dano orgânico.

Isso muda a pergunta sobre agonistas incretínicos. Se obesidade fosse apenas excesso de peso, bastaria discutir quantos quilos se perdem. Quando reconhecida como doença sistêmica, a pergunta correta é: em quais pacientes o tratamento modifica doença, complicações, função, risco cardiovascular e trajetória clínica — e a que custo, risco e necessidade de acompanhamento?

OBESIDADE SARCOPÊNICA

Fenótipo em que excesso de adiposidade coexiste com baixa massa e função muscular. DXA é método de referência; bioimpedância pode ser alternativa prática. Peso e IMC isolados podem esconder o componente de maior risco funcional.

FONTES DE ENQUADRAMENTO

EASO — framework de diagnóstico, estadiamento e manejo
ESPEN/EASO — consenso sobre obesidade sarcopênica

Medicamentos para obesidade no SUS: o anúncio chegou antes da incorporação

A promessa é relevante. O fato regulatório ainda é estudo, avaliação de tecnologia e definição de protocolo.

Em 17 de setembro, durante agenda em Montes Claros, o Ministério da Saúde apresentou a futura oferta de medicamentos para obesidade no SUS como um direito a ser construído de forma responsável. O comunicado oficial descreve avaliação, estudo em andamento e preparação de protocolo — não uma incorporação já concluída.

Entre as iniciativas citadas está o Real-Bari, no Grupo Hospitalar Conceição, que deverá acompanhar 250 pacientes. Um resultado individual, como a perda ponderal já divulgada de um participante, é anedota clínica; não é evidência suficiente para uma política nacional.

CONTRAPONTO • T36

Em 16 de setembro, a Anvisa proibiu importação, armazenamento, distribuição, comercialização, propaganda e uso da T36. O produto não possui registro sanitário no Brasil e não teve segurança e eficácia avaliadas pela Agência.

Nem acesso sem regulação, nem regulação indiferente ao problema de acesso.

O QUE AINDA NÃO ACONTECEU

Não houve nesta semana portaria final de incorporação nem protocolo nacional publicado definindo elegibilidade, financiamento, seguimento ou critérios de interrupção.

O QUE MUDOU

Intenção pública de construir acesso + interdição sanitária da T36 na mesma semana.

POR QUE IMPORTA

Para quem, em qual indicação, por quanto tempo, contra qual alternativa e dentro de qual percurso assistencial. “GLP-1” não é uma intervenção única.

FONTES PRIMÁRIAS

Ministério da Saúde, 17/09/2026
Anvisa, 16/09/2026 — Resolução-RE nº 3.626/2026
Conitec — precedente de 2025

Mover o corpo sem passar no tribunal

O mesmo reframe da abertura vale aqui. Hábito não é penitência. Dia sem movimento não é falha moral. A ferramenta oferece; o humano segura o HOLD.

HUMAN_GATE — yield para quem paga a conta · iniciativa sem voluntarismo · pedagogia do erro.

O QUE ESTA CAIXA NÃO FAZ

Não conta streak punitivo. Não transforma IMC em nota. Não chama ninguém de sedentário. Não prescreve treino, dieta nem fármaco. Não é SaMD.

SE QUISER, HOJE

Caminhar

Sair. Voltar. Sem meta de passos como sentença.

Parar

HOLD. A ferramenta cala. Quem paga a conta decide o próximo ato.

Anotar o que aconteceu

Erro e interrupção entram como matéria, não como culpa.

REFRAME

Incentivo ≠ julgamento. Acelerar o hábito só vale se a etapa que descobre o excesso — dor, risco, recusa — continuar no caminho.

Engenharia epistêmica

Frameworks para otimizar respostas de IA sem subordinar o clínico ao contexto que só parece inteligente. Canal Lucas HR (MD), 02/05/2026.

Vídeo do autor: <https://youtu.be/5XilHabelck>

POR QUE ESTÁ AQUI

Cruza o item 04 da edição (saber quando não decidir) com o bloco *Aos que ensinam*. Não disputa capa com GLP-1 nem com sarampo.

CROSSLINK

YouTube Substack VIA
Arquivo

O ensaio vizinho no Substack é *A Máquina Não Pensa. Mas Decide.* (28/03/2026). O vídeo não foi amarrado a um post único nesta passada.

YIELD DO EMBED

youtube-nocookie. Ainda assim o player é superfície de terceiro. Quem não quiser o iframe usa o link. Legenda automática do YouTube ≠ legenda editorial da VIA.

O QUE FICA DA SEMANA

- Anunciar acesso não é incorporar uma tecnologia.
- Autorizar ou estudar uma tecnologia não é demonstrar benefício em qualquer população.
- Um modelo capaz de responder não é necessariamente capaz de reconhecer quando não deveria responder.
- Acelerar um processo regulatório só é avanço se a velocidade não apagar as etapas que existem para descobrir quando estamos errados.

Ciência e tecnologia entram no cuidado por uma cadeia de decisões. A qualidade dessa cadeia talvez importe tanto quanto a novidade que circula por ela.

NOTA DE MÉTODO

Fatos regulatórios e institucionais foram conferidos em fontes primárias. Declaração ministerial, protocolo de pesquisa, decisão de incorporação e autorização sanitária são categorias distintas. A edição preserva essa separação.



DR LUCAS HR – MÉDICO GENERALISTA (FMRP-USP)
CRM-SP: 226836 | CRM-MG: 109752
INICIATIVA VIA – VIDA INTEGRADA E AUTÔNOMA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA A SERVIÇO DO CUIDADO.

FOTO · 40º CONGRESSO CREMESP · 2026

Revista Eletrônica VIA · Saúde na Última Semana · edição de 20.09.2026.